



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PANDUAN
PENINGKATAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 633.17/I-PND/DIR/VII/2025

Tentang
Panduan Peningkatan Komunikasi Yang Efektif

Disusun oleh :
Penanggung jawab BAB SKP



(**Khusnul Khotimah, S. Kep, Ns.)**

Disetujui oleh :
Authorized Person



(**Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP**)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(**dr. Nur Mazidah**)

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 633.17/I-PND/DIR/VII/2025**

TENTANG

PANDUAN PENINGKATAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dibutuhkan tindakan yang komprehensif dan responsif terhadap kejadian tidak diinginkan di fasilitas pelayanan kesehatan agar kejadian serupa tidak terulang kembali;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali penyelenggaraan Identifikasi Pasien dengan Peraturan Direktur tentang Panduan Peningkatan Komunikasi Yang Efektif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1128 Tahun 2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
8. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada;
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 773.145/I-KEP/DIR/VI/2023 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT TENTANG PANDUAN
PENINGKATAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF**

Pasal 1

- (1) Rumah sakit menerapkan proses untuk meningkatkan efektivitas komunikasi lisan dan/ atau telepon antara profesional pemberi asuhan (PPA)
- (2) PPA adalah kelompok profesional pemberi ashan, meliputi dokter, perawat bidan, apoteker, ahli gizi.

-
- (3) Proses pelaporan hasil kritis pada pemeriksaan diagnostic termasuk POCT dan proses komunikasi saat serah terima (*hand over*) termasuk dalam komunikasi efektif.

Pasal 2

- (1) Komunikasi efektif adalah komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dipahami oleh resipien/ penerima pesan.
- (2) Komunikasi dapat dilakukan secara lisan, tertulis, dan elektronik.

Pasal 3

- (1) Metode, formulir dan alat bantu ditetapkan sesuai dengan jenis komunikasi agar dapat dilakukan secara konsisten dan lengkap
- (2) Metode komunikasi saat menerima intruksi melalui telepon adalah : menulis/ menginput ke computer – membackan – konfirmasi kembali (*writedown, read back, confirmation*)
- (3) Saat melaporkan metode yang digunakan adalah *Situation – Background – Assessment – Recommendation* (SBAR)
- (4) Metode komunikasi saat melaporkan nilai kritis pemeriksaan diagnostic melalui telpon juga dengan menggunakan menulis/ menginput ke computer – membackan – konfirmasi kembali (*writedown, read back, confirmation*)
- (5) Metode komunikasi saat serah terima antar ruangan dan atau di salam ruangan menggunakan formulir khusus.

Pasal 4

- (1) *Hand over* dalam rumah sakit mencakup antar PPA
- (2) Antar unit perawatan yang berbeda di dalam rumah sakit
- (3) Dari ruang perawatan pasien ke unit layanan diagnostic

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 1 Juli 2025

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA MALANG

dr. Nurmazidah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karuniaNya Panduan Peningkatan Komunikasi Yang Efektif dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Prima Husada.

Panduan Peningkatan Komunikasi Yang Efektif ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi cara mengidentifikasi pasien dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Panduan Peningkatan Komunikasi Yang Efektif ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 1 Juli 2026

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

PANDUAN IDENTIFIKASI PASIEN

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP

Pelaksana

1. dr. Nur azidah.
2. Indah Maulhayati, S. Kep. Ns
3. Artika Wulandari, S. Kep. Ns
4. Siti Durotul Ibadiah, S. Kep. Ns
5. Fadhila Ayu Setyani, S. Kep. Ns
6. Afni Nur Ainy, S. Kep. Ns
7. Khusnul Khotimah, S. Kep. Ns
8. Wiwit Indah Yanti, S. Kep. Ns
9. Very Susanto, S. Kep. Ns
10. Murwani Suryaning S, S. Kep, Ns
11. Sherly Rosita, S. Kep, Ns
12. Dan seluruh staf di RS Prima Husada Malang

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PENGESAHAN	ii
PERATURAN DIREKTUR RS PRIMA HUSADA	iii
KATA PENGANTAR	iv
TIM PENYUSUN	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Pengertian	1
BAB II RUANG LINGKUP	2
2.1. Seluruh PPA di Rumah Sakit	2
2.2. Kepala Instalasi/ Kepala Ruang	2
2.3. Kepala Bidang	2
BAB III TATA LAKSANA	3
3.1. Tata Laksana Proses Menerima Intruksi Melalui Telepon	3
3.2. Metode Komunikasi Pelaporan Nilai Kritis	3
3.3. Metode Serah Terima (<i>handover</i>)	4
BAB IV PENUTUP	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Alur Pelaporan Hasil Kritis	5
---	---

DAFTAR TABEL

Table 3.1. Daftar Rentang Nilai Kritis Pemeriksaan Laboratorium RS Prima Husada	1
Table 3.2. Daftar Rentang Hasil Kritis Pemeriksaan Radiologi RS Prima Husada	7
Table 3.3. Komunikasi Efektif antar semua tenaga kesehatan menggunakan metode SBAR (<i>Situation, Background, Assessment, Recommendation</i>)	8

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA MALANG
NOMOR 633.17/I-PND/DIR/VII/2025
TENTANG
PANDUAN PENINGKATAN KOMUNIKASI
YANG EFEKTIF

PANDUAN PENINGKATAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Sasaran keselamatan pasien adalah untuk mendorong rumah sakit agar melakukan perbaikan spesifik dalam keselamatan pasien. Sasaran ini menyoroti bagian-bagian yang bermasalah dalam pelayanan rumah sakit dan menjelaskan bukti serta solusi dari consensus para ahli atas permasalahan ini. System yang baik akan berdampak pada peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan keselamatan pasien. Salah satu sasaran keselamatan pasien salah satu diantaranya adalah komunikasi efektif.

Komunikasi efektif adalah komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dipahami oleh resipien/ penerima pesan akan mnegurangi potensi terjadinya kesalahan serta meningkatkan keselamatan pasien. Komunikasi yang paling banyak memiliki potensi terjadinya kesalahan adalah pemberian intruksi secara lisan atau melalui telepon, pelaporan hasil kritis dan saat serah terima. Latar belakang suara, gangguan, nama obat yang mirip dan istilah yang tidak umum sering kali menjadi masalah.

Proses komunikasi efektif dilakukan antara professional pemberi asuhan (PPA) dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan. Maka dengan itu dengan adanya panduan ini bertujuan agar lebih meningkatkan kembali komunikasi yang efektif.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Maksud disusunnya Panduan Peningkatan Komunikasi Yang Efektif adalah untuk digunakan sebagai panduan atau acuan bagi seluruh PPA dalam melakukan komunikasi yang efektif.
2. Tujuan
 - a. Melakukan komunikasi lisan dan/atau telepon diantara PPA secara efektif
 - b. Melakukan proses pelaporan hasil kritis pada pemeriksaan diagnostic termasuk *point of care testing* (POCT) secara efektif dan terstandar
 - c. Proses komunikasi serah terima/ *hand over* antar PPA, antar unit perawatan yang berada dalam rumah sakit, dan dari ruang perawatan pasien ke unit layanan diagnostic terjadi dengan benar.
 - d. Mengurangi potensi terjadinya kesalahan dalam komunikasi dan meningkatkan keselamatan pasien

1.3. PENGERTIAN

Komunikasi efektif adalah komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas dan dipahami oleh resipien/ penerima pesan. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan, tertulis, dan elektronik. Dengan menggunakan metode *writedown, read back, confirmation*. Sedangkan metode komunikasi pada saat melaporkan kondisi pasien kepada DPJP (dokter penanggung jawab pasien) menggunakan metode *Situation – Background – Assessment – Recommendation (SBAR)*.

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Panduan Peningkatan Komunikasi Yang Efektif meliputi: Rawat Jalan, Rawat Inap, Unit Darurat, Kamar Operasi, *Intensive Care* Unit, dan Unit Layanan Diagnostik. Pelaksana panduan ini adalah para professional pemberi asuhan (PPA)

2.1. Seluruh PPA di Rumah Sakit

1. Memahami dan menerapkan metode komunikasi efektif
2. Memastikan metode komunikasi efektif dilakukan secara benar, termasuk pada saat pelaporan kondisi pasien, pelaporan hasil kritis, dan pada saat serah terima/ *hand over*.
3. Melaporkan kejadian salah dalam komunikasi efektif

2.2. Kepala Instalasi/ Kepala Ruang

1. Memastikan seluruh staf di Instalasi memahami tentang komunikasi efektif dan menerapkannya.
2. Menyelidiki semua insidens salah komunikasi efektif dan memastikan terlaksananya suatu tindakan untuk mencegah terulangnya kembali insidens tersebut.

2.3. Kepala Bidang

1. Memantau dan memastikan Panduan Peningkatan Komunikasi Yang Efektif dikelola dengan baik oleh Kepala Instalasi/ Kepala Ruang.
2. Menjaga standarisasi dalam menerapkan panduan Peningkatan Komunikasi Yang Efektif.

BAB III TATA LAKSANA

Komunikasi dapat berbentuk verbal, elektronik, atau tertulis. Komunikasi yang jelek dapat membahayakan pasien. Komunikasi yang rentan terjadi kesalahan adalah saat perintah lisan atau perintah melalui telepon, komunikasi verbal, saat menyampaikan hasil pemeriksaan kritis yang harus disampaikan lewat telpon. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan aksen dan dialek. Pengucapan juga dapat menyulitkan penerima perintah untuk memahami perintah yang diberikan. Misalnya, nama-nama obat yang rupa dan ucapannya mirip (*look alike, soundalike*), seperti phenobarbital dan phentobarbital, serta lainnya. Pelaporan hasil pemeriksaan diagnostik kritis juga merupakan salah satu isu keselamatan pasien.

Untuk melakukan komunikasi secara verbal atau melalui telpon dengan aman dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemesanan obat atau permintaan obat secara verbal sebaiknya dihindari
2. Dalam keadaan darurat karena komunikasi secara tertulis atau komunikasi elektronik tidak mungkin dilakukan maka harus ditetapkan panduannya meliputi permintaan pemeriksaan, penerimaan hasil pemeriksaan dalam keadaan darurat, identifikasi dan penetapan nilai kritis, hasil pemeriksaan diagnostik, serta kepada siapa dan oleh siapa hasil pemeriksaan kritis dilaporkan
3. Prosedur menerima perintah lisan atau lewat telpon meliputi penulisan secara lengkap permintaan atau hasil pemeriksaan oleh penerima informasi, penerima membaca kembali permintaan atau hasil pemeriksaan, dan pengirim memberi konfirmasi atas apa yang telah ditulis secara akurat

Penggunaan singkatan-singkatan yang tidak ditetapkan oleh rumah sakit seringkali menimbulkan kesalahan komunikasi dan dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, rumah sakit diminta memiliki daftar singkatan yang diperkenankan dan dilarang. Serah terima asuhan pasien (*hand over*) di dalam rumah sakit terjadi :

1. Antar-PPA seperti antara staf medis dan staf medis, antara staf medis dan staf keperawatan atau dengan staf klinis lainnya, atau antara PPA dan PPA lainnya pada saat pertukaran shift
2. Antar berbagai tingkat layanan di dalam rumah sakit yang sama seperti jika pasien dipindah dari unit intensif ke unit perawatan atau dari unit darurat ke kamar operasi
3. Unit rawat inap ke unit layanan diagnostik atau unit tindakan seperti radiologi atau unit terapi fisik.

Gangguan komunikasi dapat terjadi saat dilakukan serah terima asuhan pasien yang dapat berakibat kejadian yang tidak diharapkan (*adverse event*) atau kejadian sentinel. Komunikasi yang baik dan terstandar baik dengan pasien, keluarga pasien, dan pemberi layanan dapat memperbaiki secara signifikan proses asuhan pasien.

3.1. Tata Laksana Proses Menerima Instruksi Melalui Telepon

1. Metode komunikasi saat menerima instruksi melalui telpon adalah : menulis – membacakan – konfirmasi kembali
2. Menulis yang dimaksud adalah dilakukan di formulir catatan perkembangan pasien terintegrasi untuk pasien lama dan pasien baru di form SBAR
3. Format penulisan dengan menggunakan SOAP
4. Membacakan dan konfirmasi kembali adalah menanyakan kembali kepada pemberi pesan dengan membacakan kembali pesan yang disampaikan dan apakah sudah sesuai dengan instruksi yang diberikan

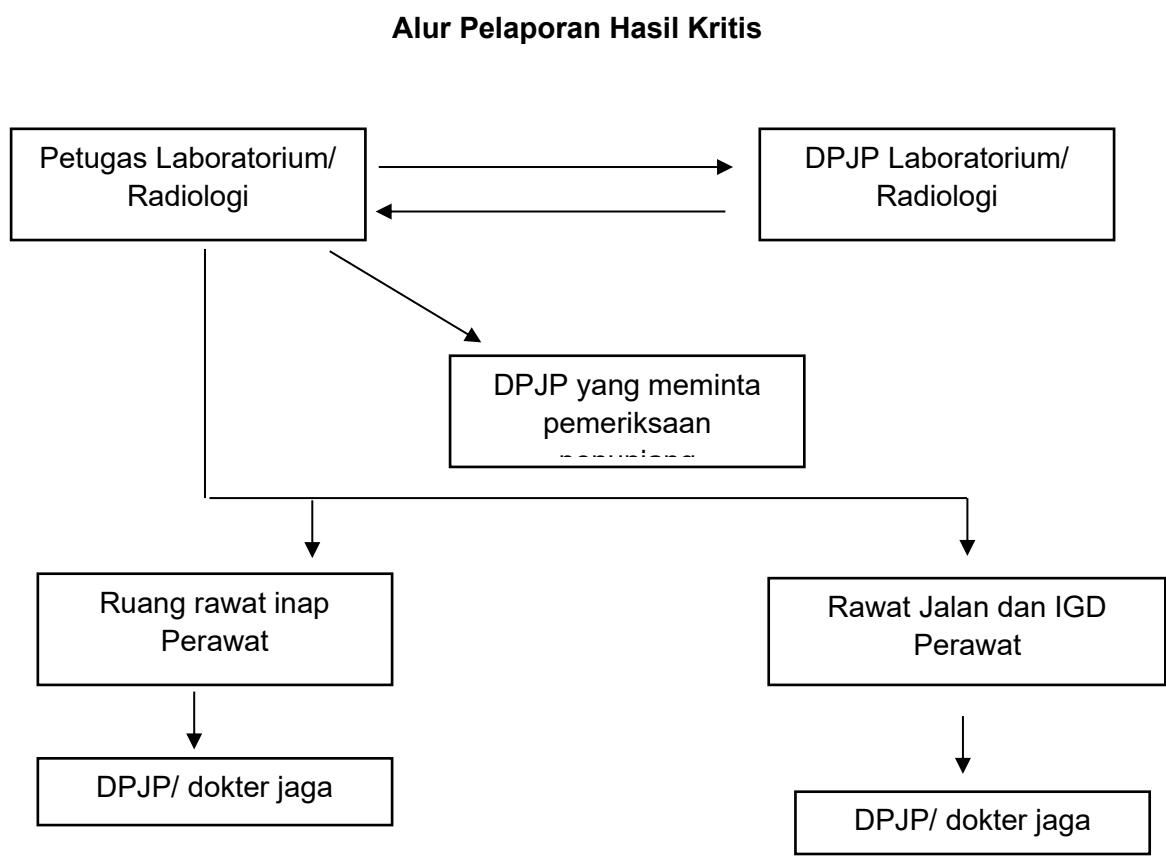
3.2. Metode Komunikasi Pelaporan Nilai Kritis

1. Hasil kritis di definisikan sebagai varian dari rentang normal yang menunjukkan adanya kondisi patologis yang berisiko tinggi atau mengancam nyawa, yang dianggap gawat atau darurat, dan mungkin memerlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kejadian yang tidak diinginkan.
2. Pemeriksaan diagnostic mencakup semua pemeriksaan seperti laboratorium, pencitraan/ radiologi, diagnostic jantung juga pada hasil pemeriksaan yang dilakukan di tempat tidur pasien (*pointof – care testing* (POCT))
3. Pada pasien rawat inap pelaporan hasil kritis dapat dilaporkan melalui perawat yang akna meneruskan laporan kepada DPJP yang meminta pemeriksaan.
4. Rentang waktu pelaporan hasil kritis ditentukan kurang dari 30 menit sejak hasil di verifikasi oleh PPA yang berwenang di unit pemeriksaan penunjang diagnostic.
5. Mekanisme pelaporan hasil kritis adalah sebagai berikut :
 - a. Dokter/ petugas laboratorium, radiologi dan perawatan yang melakukan pengecekan penunjang menyampaikan hasil kritis ke DPJP. Bila DPJP tidak bisa dihubungi, dokter/ petugas laboratorium, radiologi dan perawatan yang melakukan langsung menghubungi dokter/ perawat unit rawat inap, rawat jalan dan unit gawat darurat.
 - b. Dokter/ petugas yang melaporkan hasil kritis mencatat tanggal dan waktu menelpon, nama lengkap petugas kesehatan yang dihubungi dan nama lengkap yang menelepon di buku pelaporan hasil kritis.
 - c. Dokter/ perawat ruangan yang menerima hasil kritis menggunakan tehnik menulis – membacakan – konfirmasi kembali, proses pelaporan ini ditulis di dalam rekam medis (form catatan perkembangan terintegrasi). Sedangkan petugas laboratorium atau radiologi menulis di buku pelaporan hasil kritis.
 - d. Dokter/ perawat ruangan yang menerima laporan hasil kritis langsung menghubungi DPJP yang merawat pasien.
 - e. Dokter/ perawat ruangan yang menerima laporan hasil kritis dan menghubungi DPJP yang merawat pasien harus mencatat tindakan yang diambil untuk pasien atau informasi lain terkait klinis
 - f. Semua hasil kritis/ interpretasi selanjutnya disampaikan melalui formulir hasil pemeriksaan sesuai dengan SPO Penyerahan Hasil.
 - g. Untuk pasien rawat jalan, hasil kritis harus dilaporkan kepada dokter yang meminta pemeriksaan dan harus menyampaikan hasil kritis ke pasien.
 - h. Dokter yang dilaporkan tentang hasil kritis yang perlu diwaspadai tersebut, bertanggung jawab terhadap interpretasi hasil dan pengambilan tindakan terhadap pasien

3.3. Metode Serah Terima (*handover*)

1. Metode komunikasi saat serah terima di standarisasi pada jenis serah terima yang sama antar ruangan rawat inap. Jika antar ruangan yang berbeda, misalkan dari IGD ke ruang rawat inap dapat menggunakan metode, formulir dan alat yang berbeda.
2. Jenis serah terima di dalam rumah sakit dapat mencakup :
 - a. Antar PPA (misalnya, antar dokter, dari dokter ke perawat, antar perawat, dan seterusnya)
 - b. Antar unit perawatan yang berbeda di dalam rumah sakit (misalnya saat pasien dipindahkan dari ruang perawatan intensif ke ruang perawatan atau dari instalasi gawat darurat ke ruang operasi), dan
 - c. Dari ruang perawatan pasien ke unit layanan diagnostic seperti radiologi atau fisioterapi.

3. PPA mencatat serah terima di formulir atau di buku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan di dalamnya ada kepada siapa tanggung jawab pelayanan diserahkan, kemudian juga ada tanda tangan, tanggal dan waktu pencatatan.



Gambar 3.1. Alur Pelaporan Hasil Kritis

Keterangan :

1. 10 menit pertama adalah pelaporan dari Laboratorium/ radiologi ke DPJP yang meminta pemeriksaan sejak ditemukannya hasil kritis dan sudah dikonfirmasi oleh dokter penanggung jawab Laboratorium atau radiologi.
2. 10 menit kedua adalah bagian Laboratorium/ Radiologi melaporkan kepada perawat ruangan sesuai dengan unit yang meminta
3. 10 menit selanjutnya adalah perawat unit melaporkan kepada DPJP terkait dan mendokumentasikan di formulir catatan perkembangan pasien (CPPT)
4. Semua wajib dilaporkan maximal 30 menit dari waktu ditemukannya hasil kritis dan sudah dikonfirmasi oleh dokter penanggung jawab Laboratorium atau radiologi.

Table 3.1. Daftar Rentang Nilai Kritis Pemeriksaan Laboratorium RS Prima Husada

Tes Pemeriksaan	Nilai Kritis	Satuan
Hematologi		
HCT	< 20 atau > 60	%
Hb	< 7 atau > 20	g/dl
Trombosit Dewasa	< 40.000 atau > 1.000.000	10 ³ /ul
Leukosit	< 2.000 atau > 30.000	10 ³ /ul
APTT	> 100	Detik
PPT	> 30 atau > 3x nilai kontrol	Detik
Penemuan Sel Blast Dihapusan	-	-

Darah Tepi		
Penemuan Sel Asing Disumsum Tulang	-	-
Kimia Klinik		
Troponin I	> 100	ng/dl
CKMB	> 200	uL
Glukosa	< 45 atau > 800	mg/dl
Glukosa Neonatus	< 30 atau > 300	mg/dl
Creatinin	> 5,0	mg/dl
Elektrolit		
Natrium	< 120 atau > 160	mmol/L
Kalium	< 2,8 atau > 6,2	mmol/L
Kalium Neonatus	< 2,5 atau > 8,0	mmol/L
Cairan Tubuh (Pleura, Serebrosinal, Asites)		
Glukosa	< 80 Kadar glukosa darahnya	%
Total Protein	> 45	mg/dl
Leukosit	> 10	/ul
Pengecatan Bakteri	(+)	-
Ditemukan Sel Asing		-
Urinalisa		
Glukosaria	> 2+	
Keton	> 2+	
Ditemukan Kristal Patologis	Uric Acid, Sistein, Leusin, Tirosin	
Albuminaria	> 2+	
Eritrosit	> 2+	
Leukosit	> 2+	

Table 3.2. Daftar Rentang Hasil Kritis Pemeriksaan Radiologi RS Prima Husada

1. Daftar Hasil Kritis Foto Rontgen

No	Pemeriksaan	Posisi	Hasil Kritis
1	Skull	AP Lateral	1. Open Fraktur Os Cranium 2. Open Fraktur Os Mandibula 3. Open Fraktur Os Temporalis (Epidural Hematome) 4. Cerebral Infark 5. COB
2	Cervical	AP Lateral Oblique	Open Fraktur Os Cervical
3	Shoulder	AP	1. Open Fraktur Hip Joint Humerus 2. Dislokasi Shoulder
4	Clavicula	AP	Open Fraktur Os Clavicula
5	Thorax	AP Lateral	1. Open Fraktur Costae > 2 Costae Yang Sama (Open, Closed, Tension) 2. Hematothorax/Pneumothorax
6	Humerus	AP Lateral	Open Fraktur Os Humerus 1/3 Distal
7	Antebrachii	AP Lateral	1. Open Fraktur Os Radius 2. Open Fraktur Os Ulna 3. Dislokasi Elbow 4. Dislokasi Wrist

8	Manus	AP Oblique	1. Open Fraktur Os Metacarpal 2. Open Fraktur Os Carpal 3. Dislokasi Dip 4. Dislokasi Pip
9	Abdomen	AP	Trauma
10	Pelvis	AP	1. Dislokasi Hip Joint 2. Syok Hipovolemia Merobek Arteri Abdominalis
11	Femur	AP Lateral	Open Fraktur Os Femur
12	Cruris	AP Lateral	1. Open Fraktur Os Tibia 2. Open Fraktur Os Fibula 3. Dislokasi Knee Joint
13	Pedis	AP Oblique	1. Open Fraktur Os Metatarsal 2. Open Fraktur Os Tarsal
14	Lumbal	AP Lateral	Spondilolistesis
15	Ankle	AP Oblique	Dislokasi Ankle

2. Daftar Hasil Kritis USG

No	Pemeriksaan	Hasil Kritis
1	Skull	Intracerebral Hematoma (Ich)
2	Thorax	Trauma Thorax
3	Abdomen	Trauma Abdomen Pada Intra Peritoneum Acute Appendicitis
4	Mammae	Stenosis Mammae Pada Arteri Mammaria
5	Thyroid	Thyroid Dengan Trauma Pada Neck

3. Daftar Hasil Kritis CT-Scan

No	Pemeriksaan	Hasil Kritis
1	Skull	Intracerebral Hematoma (Ich)
2	Thorax	Trauma Thorax
3	Abdomen	Trauma Abdomen Pada Intra Peritoneum

Table 3.3. Komunikasi Efektif antar semua tenaga kesehatan menggunakan metode SBAR
(*Situation, Background, Assessment, Recommendation*)

No	Metode SBAR	Penerapan antar shif dinas/ serah terima pasien	Penerapan antar perawat dengan dokter lewat telepon
1.	<i>Situation :</i> Bagaimana situasi yang akan dibicarakan/ dilaporkan? 1. Mengidentifikasi nama diri petugas dan pasien 2. Diagnose medis 3. Apa yang terjadi dengan pasien	1. Nama : Tn. X, usia 35 tahun, tanggal masuk 10 Juli 2022 sudah 3 hari perawatan 2. DPJP : dr. X SP. PD, diagnosis : Gagal Ginjal Kronik 3. Masalah keperawatan : Hipervolemia dan Nausea	1. Selamat pagi dokter, saya perawat S dari Irna 3A 2. Melaporkan pasien atas nama Tn. X mengalami penurunan pengeluaran urin 40 cc/24 jam, mengalami sesak
2.	<i>Background :</i> Apa latar belakang informasi klinis yang berhubungan dengan situasi?	1. Pasien bedrest total, urine 50 cc/24 jam, balance cairan 1000cc/ 24 jam. 2. Mual tetap ada selama dirawat, ureum 300 mg/dl.	1. Diagnosa medis gagal ginjal kronik, tanggal masuk 10 Juli 2022, program HD hari Senin - Kamis.

	1. Obat saat ini dan alergi 2. Tanda – tanda vital terbaru 3. Hasil laboratorium/ radiologi : tanggal dan waktu tes dilakukan dan hasil tes sebelumnya untuk perbandingan 4. Riwayat medis 5. Temuan hasil klinis terbaru	3. Pasien program HD 2x seminggu Senin dan Kamis. 4. Terpasang infuse NaCl 10 tetes/menit 5. Dokter sudah menjelaskan penyakitnya tentang gagal ginjal kronik 6. Diet : rendah protein 1 gram	2. Tindakan yang sudah dilakukan posisi semi fowler, sudah terpasang dower kateter, pemberian oksigen 3 liter/menit 15 menit yang lalu. 3. Obat injeksi diuretic furosemide 3 x 1 amp 4. TD 150/80 mmHg, RR 30x/menit, Nadi 100 x/menit, udem ekstremitas bawah dan asites 5. Hasil laboratorium terbaru : Hb 9 mg/dl, albumin 3, ureum 300 mg/dl 6. Kesadaran composmentis, bunyi nafas rhonki +.
3.	<i>Assessment :</i> Berbagai hasil penilaian klinis perawat 1. Apa temuan klinis? 2. Apa analisis dan pertimbangan perawat?. 3. Apakah masalah ini parah atau mengancam kehidupan?	1. Kesadaran compos mentis, TD 150/80 mmHg, Nadi 100x/menit, suhu 37°C, RR 20x/menit, udem pada ekstremitas bawah, tidak sesak napas, urine sedikit, eliminasi faeses baik 2. Hasil laboratorium terbaru : Hb 9 mg/dl, albumin 3, ureum 300 mg/dl 3. Pasien masilmengeluar mual	1. Saya pikir masalahnya adalah hipervolumia dan Nausea 2. Pasien tampak tidak stabil
4.	<i>Recommendation :</i> Apa yang perawat inginkan terjadi dan kapan? 1. Apa tindakan /rekomendasi yang diperlukan untuk memperbaiki masalah? 2. Apa solusi yang bisa perawat tawarkan kepada dokter? 3. Apa yang perawat butuhkan dari dokter untuk memperbaiki kondisi pasien? 4. Kapan waktu yang perawat harapkan tindakan ini terjadi?	1. Awasi balance cairan 2. Batasi asupan cairan 3. Konsul ke dokter untuk pemasangan dower kateter 4. Pertahankan pemberian pemberian diuretic injeksi furosemide 3x 1 amp 5. Bantu pasien memenuhi kebutuhan dasar pasien 6. Jaga aseptik dan antiseptik setiap melakukan prosedur	1. Haruskah saya mulai dengan pemberian oksigen NRBM? 2. Apa advise dokter? Perlukah peningkatan diuretic atau syringepump? Apakah dokter akan memindahkan pasien ke ICU?

BAB IV PENUTUP

Komunikasi efektif adalah komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dipahami oleh resipien/ penerima pesan. Kesalahan bisa saja terjadi jika komunikasi efektif tidak berjalan sebagaimana mestinya. Komunikasi efektif juga merupakan salah satu dari sasaran keselamatan pasien. Semakin baik komunikasi baik dalam secara lisan, tertulis, dan elektronik maka akan semakin baik pula mutu Rumah Sakit.

Pelaksana panduan ini adalah para tenaga kesehatan (medis, perawat, bidan, farmasi, dan tenaga kesehatan lainnya) yang bekerja di Rumah Sakit. Semoga dengan adanya panduan ini dapat meningkatkan komunikasi para professional pemberi asuhan (PPA) yang efektif, tepat waktu, akurat, lengkap, tidak mendua (*ambiguous*), dan dapat diterima oleh penerima informasi yang bertujuan mengurangi kesalahan-kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien.

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 1 Juli 2025
Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah